



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : منى جابر محمود العاصي
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : البساتين
رقم البطاقة : 27501011708863 رقم التليفون : 01288415585
العنوان : ..
العمر (تاريخ الميلاد) : 01-01-1975 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 24-09-2026

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (.....)
المقرر بما فيه
التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة:
الوظيفة:
الوظيفة:
التوقيع:
التوقيع:
التوقيع:
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير المستشفى.
تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / د. / د. / د. /

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: منى جابر محمود العاصي National ID: 27501011708863	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



منى
جابر محمود العاصي
٦ ش جامع حسنين-ش مهران
البيساتين - القاهرة

١٩٧٥/٠١/١١
٢٧٥٠١٠١١٧٠٨٨٦٣
LA6874169

١٢٨٨٤١٥٥٨٥

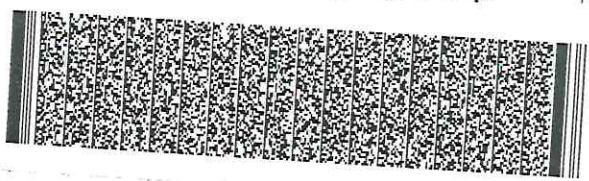
٤

٢٠٢٥/٠٣
٢٧٥٠١٠١١٧٠٨٨٦٣
ربة منزل

أنثى
مسلمة
اشرف سيد اسماعيل احمد
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٢/٢٨

متزوجة





Patient's Name: Mona Jaber Mahmoud Al-Asi
Date: 2026-07-29
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: Left retroareolar mass and nipple retraction..

Findings:

Right breast.

- Scattered densities of glandular tissue (ACR b)
- No speculations, masses asymmetry , distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated homogeneous glandular appearance yet no solid or cystic lesions.
- **12 o'clock clusterd mircocyst measuring (12 x 4 mm).**
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left breast.

- Scattered densities of glandular tissue (ACR b)
- **Retroareolar irregular speculated high density mass lesion associated with nipple retraction.**
- **Ultrasound demonstrated retroareolar irregular mass assocaited with intraductal extension measuring (1.5 x 1.6 x 2.4 cm) .**
- Normal skin.
- Non specific axillary LNs .

Conclusion:-

- **Right breast (BIRADS 2): clustered microcyst .**
- **Left breast (BIRADS 5): Retroareolar suspicious mass.**

For biopsy .

Prof.MONA ZAKY

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



منى
جابر محمود العاصي
٦ ش جامع حسنين - ش مهران
البساتين - القاهرة

١٩٧٥/٠١



٢٧٥٠١٠١١٧٠٨٨٦٣

LA6874169

National ID - Front
[DOCTYPE:ID (15-11)]

البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٢/٢٨



Patient's Name:

Mona Jaber Mahmoud Al-Asi

Date:

2026-07-29

Referred by:

Prof.Dr. no doctor

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: Left retroareolar mass and nipple retraction..

Findings:

Right breast.

- Scattered densities of glandular tissue (ACR b)
- No speculations, masses asymmetry , distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound demonstrated homogeneous glandular appearance yet no solid or cystic lesions.**
- **12 o'clock clustered microcyst measuring (12 x 4 mm).**
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left breast.

- Scattered densities of glandular tissue (ACR b)
- **Retroareolar irregular speculated high density mass lesion associated with nipple retraction.**
- **Ultrasound demonstrated retroareolar irregular mass associated with intraductal extension measuring (1.5 x 1.6 x 2.4 cm) .**
- Normal skin.
- Non specific axillary LNs .

Conclusion:-

- **Right breast (BIRADS 2): clustered microcyst .**
- **Left breast (BIRADS 5): Retroareolar suspicious mass.**

For biopsy .

Prof.MONA ZAKY

Patient Name	منى جابر محمد	Case No.	357584
Sex/Age	Female 51 Y	Patient No.	25778
Registered Date	12/8/2026 09:43:53 AM	Referred By Dr.	Interventional Radiology
Validation Date	20/9/2026 02:45:34 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	24/9/2026 09:08:46 AM	Pathology No.	2548/26

Pathology Report

Clinical Data: Left breast mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 12/08/2026. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:

- Multiple fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.5 cm & 1.0 cm long, totally submitted.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for:
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), SISH, & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

- Histologic type: Invasive lobular carcinoma.
- Histologic grade: 2 (differentiation 3, pleomorphism 2, mitosis 1).
- DCIS: Absent.
- Microcalcification: Absent.
- Angiolinvasion: Absent.
- Perineural invasion: Absent.
- Tumor infiltrating lymphocytes (TILs): 1%.

Results:

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- ER: Strong nuclear reaction in 95% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 99% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: Moderate complete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 2+).
- SISH: Amplified with clusters.
- (Average Her2 copy No.: (6), Her2/CEP17 ratio: (4))
- Ki67%: 20%.

Conclusion:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:

- Invasive lobular carcinoma, Grade 2.

IPT:



Gustave Roussey International Egypt Pathology Lab
 جوستاف رويسى انترناشيونال - مصر - عين شمس الجبل الشرقى



Patient Name	منى جابر محمّد	Case No.	357584
Sex/Age	Female 51 Y	Patient No.	25778
Registered Date	12/8/2026 09:43:53 AM	Referred By Dr.	Interventional Radiology
Validation Date	20/9/2026 02:45:34 PM	Branch	Gustave Roussey
Reporting Date	24/9/2026 09:08:46 AM	Pathology No.	2548/26

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Equivocal (score 2+).
- SISH: Amplified with clusters.
- Ki67%: 20%.

**Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

** Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

ISH groups:

The ratio is calculated and the results is interpreted as:

- Group I (Positive): HER2/CEP17 ratio is more than 2 & Average HER2 copy number/ cell is more than 4.
- Group II (Negative): HER2/CEP17 ratio is more than 2 & Average HER2 copy number/ cell is less than 4. (Recounting give the same result).
- Group III (Positive): HER2/CEP17 ratio is less than 2 & Average HER2 copy number/ cell is more than 6 (Recounting give the same result).
- Group IV (Negative): HER2/CEP17 ratio is less than 2 & Average HER2 copy number/ cell is more than 4 but less than 6. (Recounting give the same result).
- Group V (Negative): HER2/CEP17 ratio is less than 2 & Average HER2 copy number/ cell is less than 4.

Signature

Prof. Dr. Maha Guinei, MD, PhD.
Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim, MD.

2020.10.11 17:08

Advanced Clinical Exam

مستشفى الجليل

التي اليسار

طبيعي	تراجع أو تغيير في اتجاه الحلمة
بروز الأوردة	تقرحات بالجند أو الحمة
تغير في الشكل أو الحجم	أحزانت غير طبيعية
حدوث تورف	الشعر بلام بالابط
طفح	الشعر بسمك عام
تجاويد بالجند	ألم بالثدي
تغير الجند أما بشفة	قدم محسوس
تغير البركتال	تم إستقصاء الثدي
الإحصار	X

Maximum mass dimension (mm):

Side:

- Right
- Left
- Bilateral

Quadrant:

- UOQ
- UIQ
- LOQ
- LIQ
- Central and retroareolar
- Axilla

Imaging study requested:

- Sonography
- Mammosonography
- MRI breasts

التي اليمين

طبيعي	تراجع أو تغيير في اتجاه الحلمة
بروز الأوردة	تقرحات بالجند أو الحمة
تغير في الشكل أو الحجم	أحزانت غير طبيعية
حدوث تورف	الشعر بلام بالابط
طفح	الشعر بسمك عام
تجاويد بالجند	ألم بالثدي
تغير الجند أما بشفة	قدم محسوس
تغير البركتال	تم إستقصاء الثدي
الإحصار	X

تحت الجند

Let rest areolar mass @ nipple retraction

for BS M
-VE F-HX

دعاء صبور

Patient's Name: Mona Jaber Mahmoud Al-Asi
Date: 2026-07-29
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: Left retroareolar mass and nipple retraction..

Findings:

Right breast.

- Scattered densities of glandular tissue (ACR b)
- No speculations, masses asymmetry , distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated homogeneous glandular appearance yet no solid or cystic lesions.
- **12 o'clock clustered microcyst measuring (12 x 4 mm)**.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left breast.

- Scattered densities of glandular tissue (ACR b)
- **Retroareolar irregular speculated high density mass lesion associated with nipple retraction.**
- **Ultrasound** demonstrated retroareolar irregular mass associated with intraductal extension measuring (1.5 x 1.6 x 2.4 cm) .
- Normal skin.
- Non specific axillary LNs .

Conclusion:-

- **Right breast (BIRADS 2): clustered microcyst .**
- **Left breast (BIRADS 5): Retroareolar suspicious mass.**

For biopsy .

Prof.MONA ZAKY

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



منى
جابر محمود العاصي
٦ ش جامع حسنين - ش مهران
البساتين - القاهرة

١٩٧٥/٠١



٢٧٥٠١٠١١٧٠٨٨٦٣

LA6874169



٢٠٢٥/٠٣ ٢٧٥.٩.١١٧.٨٨٦٣

رية منزل



أنثى مسلمة متزوجة

أشرف سيد إسماعيل أحمد

البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٢/٢٨

١



Patient's Name:

Mona Jaber Mahmoud Al-Asi

Date:

2026-07-29

Referred by:

Prof.Dr. no doctor

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: Left retroareolar mass and nipple retraction..

Findings:

Right breast.

- Scattered densities of glandular tissue (ACR b)
- No speculations, masses asymmetry , distortion or suspicious microcalcifications.
- Ultrasound demonstrated homogeneous glandular appearance yet no solid or cystic lesions.
- 12 o'clock clustered microcyst measuring (12 x 4 mm).
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left breast.

- Scattered densities of glandular tissue (ACR b)
- Retroareolar irregular speculated high density mass lesion associated with nipple retraction.
- Ultrasound demonstrated retroareolar irregular mass associated with intraductal extension measuring (1.5 x 1.6 x 2.4 cm) .
- Normal skin.
- Non specific axillary LNs .

Conclusion:-

- *Right breast (BIRADS 2): clustered microcyst .*
- *Left breast (BIRADS 5): Retroareolar suspicious mass.*

For biopsy .

Prof.MONA ZAKY

Patient Name	منى جابر محمد	Case No.	357584
Sex/Age	Female 51 Y	Patient No.	25778
Registered Date	12/8/2026 09:43:53 AM	Referred By Dr.	Interventional Radiology
Validation Date	20/9/2026 02:45:34 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	24/9/2026 09:08:46 AM	Pathology No.	2548/26

Pathology Report

Clinical Data: Left breast mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 12/08/2026. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:

- Multiple fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.5 cm & 1.0 cm long, totally submitted.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for:
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), SISH, & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

- Histologic type: Invasive lobular carcinoma.
- Histologic grade: 2 (differentiation 3, pleomorphism 2, mitosis 1).
- DCIS: Absent.
- Microcalcification: Absent.
- Angiolinvasion: Absent.
- Perineural invasion: Absent.
- Tumor infiltrating lymphocytes (TILs): 1%.

Results:

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- ER: Strong nuclear reaction in 95% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 99% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: Moderate complete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 2+).
- SISH: Amplified with clusters.
- (Average Her2 copy No.: (6), Her2/CEP17 ratio: (4))
- Ki67%: 20%.

Conclusion:

- Left breast mass, Tru-cut biopsy:
- Invasive lobular carcinoma, Grade 2.
- IPT:

Patient Name	منى جابر محمّد	Case No.	357584
Sex/Age	Female 51 Y	Patient No.	25778
Registered Date	12/8/2026 09:43:53 AM	Referred By Dr.	Interventional Radiology
Validation Date	20/9/2026 02:45:34 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	24/9/2026 09:08:46 AM	Pathology No.	2548/26

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Equivocal (score 2+).
- SISH: Amplified with clusters.
- Ki67%: 20%.

**Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

** Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

ISH groups:

The ratio is calculated and the results is interpreted as:

- Group I (Positive): HER2/CEP17 ratio is more than 2 & Average HER2 copy number/ cell is more than 4.
- Group II (Negative): HER2/CEP17 ratio is more than 2 & Average HER2 copy number/ cell is less than 4. (Recounting give the same result).
- Group III (Positive): HER2/CEP17 ratio is less than 2 & Average HER2 copy number/ cell is more than 6 (Recounting give the same result).
- Group IV (Negative): HER2/CEP17 ratio is less than 2 & Average HER2 copy number/ cell is more than 4 but less than 6. (Recounting give the same result).
- Group V (Negative): HER2/CEP17 ratio is less than 2 & Average HER2 copy number/ cell is less than 4.

Signature

Prof. Dr. Maha Guinei, MD, PhD.
Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim, MD.

طبيعي	تراخي أو تشنج في اتجاه الحمة
بروز الأوردة	تقرحات بالجند أو الحمة
تشنج في الشكل أو الحجم	أفرازات غير طبيعية
حدوث تورف	الشعر بالورام بالابط
طفح	الشعر بسمك عام
تجاويد بالجند	ألم بالثدي
تحتول الجند أما بشفة	قدم محسوس
تحتول البركتال	تم إستئصال الثدي
الإحصار	X

Maximum mass dimension (mm):

Side:

- Right
- Left
- Bilateral

Quadrant:

- UOQ
- UIQ
- LOQ
- LIQ
- Central and retroareolar
- Axilla

Imaging study requested:

- Sonography
- Mammosonography
- MRI breasts

طبيعي	تراخي أو تشنج في اتجاه الحمة
بروز الأوردة	تقرحات بالجند أو الحمة
تشنج في الشكل أو الحجم	أفرازات غير طبيعية
حدوث تورف	الشعر بالورام بالابط
طفح	الشعر بسمك عام
تجاويد بالجند	ألم بالثدي
تحتول الجند أما بشفة	قدم محسوس
تحتول البركتال	تم إستئصال الثدي
الإحصار	X

نتيجة فحص الثدي

نتيجة

Left retroareolar mass

nipple retraction

for BS M

-VE F-HX

دعاء على صبي

Patient's Name:

Mona Jaber Mahmoud Al-Asi

Date:

2026-07-29

Referred by:

Prof.Dr. no doctor

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: Left retroareolar mass and nipple retraction..

Findings:

Right breast:

- Scattered densities of glandular tissue (ACR b)
- No speculations, masses asymmetry , distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound demonstrated homogeneous glandular appearance yet no solid or cystic lesions.**
- **12 o'clock clustered microcyst measuring (12 x 4 mm).**
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left breast:

- Scattered densities of glandular tissue (ACR b)
- Retroareolar irregular speculated high density mass lesion associated with nipple retraction.
- **Ultrasound demonstrated retroareolar irregular mass associated with intraductal extension measuring (1.5 x 1.6 x 2.4 cm).**
- Normal skin.
- Non specific axillary LNs .

Conclusion:-

- **Right breast (BIRADS 2): clustered microcyst.**
- **Left breast (BIRADS 5): Retroareolar suspicious mass.**

For biopsy .

Prof.MONA ZAKY